

1. ALLGEMEINE STAMMDATEN & HOSPITATIONSRAHMEN			
Hospitant / Erfasser:	René Krieg (Pflegefachmann)	Kurs-Nr. / Träger:	WE-2026-MR-894 / MAPS Marburg
Hospitationsstelle:	UKGM Marburg – Interdisziplinäres Wundzentrum	Hospitationsdauer:	16 Unterrichtsstunden (Nachweis liegt bei)
Patienten-Code / Init.:	Frau M. K. (Anonymisiert gem. DSGVO)	Geburtsdatum / Alter:	14.05.1948 (78 Jahre)
Wohnsituation:	Einfamilienhaus Dautphetal (alleinlebend)	Pflegegrad / Dienst:	Pflegegrad 2 / Diakoniestation Gladenbach

2. GESAMTANAMNESE & KAUSALE GEFÄSSDIAGNOSTIK			
Hauptdiagnose Wunde:	Ulcus cruris venosum (CVI Stadium III nach Widmer / CEAP C6) Bestehensdauer: 14 Monate (therapierefraktär)	Lokalisation:	Linker Unterschenkel, Malleolus medialis
Relevanten Nebendiagnosen:	• Arterielle Hypertonie (medikamentös eingestellt) • Adipositas Grad I (BMI 31,2 kg/m²) • Gonarthrose beidseits (Bewegungseinschränkung)	Risikofaktoren:	☒ Immobilität / Gehstrecke <50m ☒ Chronisches Venenleiden ☐ Diabetes mellitus ☐ PAVK (ausgeschlossen)
Kausale Gefäßdiagnostik: (PAVK-Ausschluss)	Knöchel-Arm-Index (ABI / Doppler): • Rechte Seite: 1.05 (Normalbefund) • Linke Seite (Wundbein): 1.02 (Keine PAVK) • Fußpulse (A. dorsalis pedis / A. tibialis post.): beidseits kräftig tastbar.	Kompressions-Freigabe:	JA — Medizinische Indikation für Kompression (ca. 40 mmHg Arbeitsdruck) vollumfänglich gegeben.
Risiko-Assessments:	• Braden-Skala: 16 Punkte (leichtes Dekubitusrisiko) • Ernährungs-Screening (MNA): 21.5 Punkte (mögliches Risiko)	Allergien / Unverträgl.:	Keine bekannten Pflaster- oder Antiseptika-Allergien. Lanolin-Sensibilität.

3. STRUKTURIERTE WUNDBESCHREIBUNG (INITIALBEFUND WOCHE 1)		
Parameter	Soll-Kriterien nach ICW® / URGE / WUNDPIC	Konkreter Befund (Initialbefund Woche 1)
Wundgeometrie	Exakte Abmessung (Länge x Breite x Tiefe in cm/mm), Wundfläche in cm², Fotodokumentation mit Maßstab	Länge: 5,4 cm Breite: 3,0 cm Tiefe: 3 mm Wundfläche: 16,2 cm² Wundtaschen: Keine
Wundgrund (M.O.I.S.T.)	Prozentuale Anteile: Fibrin/Belag, Granulation, Epithelisation, Nekrose, Freiliegende Strukturen	• 60 % Fibrin / avitaler Biofilm (gelblich-zäh) • 35 % Blasses Granulationsgewebe • 5 % Epithelisation (am Wundrand)
Exsudation & Geruch	Menge (stark/mittel/gering), Farbe, Konsistenz, Geruch (unauffällig/fötid)	• Menge: Stark exsudierend (Verbanddurchfeuchtung <24h) • Farbe/Art: Serös-sanguinolent Geruch: Leicht fötid
Wundrand & -umgebung	Wundrand (glatt, maceriert, hyperkeratotisch, eingerollt). Umgebung (Rötung, Ödem, Dermatitis, Sklerose)	• Wundrand: Mazeriert (feucht-weißlich), eingerollt • Umgebung: Ödematös, Stauungsdermatitis, Hyperpigmentation
Infektionsstatus	Systemische vs. Lokale Infektzeichen (Rötung, Überwärmung, Schmerz, Biofilm, WAR-Score)	Kritische Kolonisierung / Mikrobieller Biofilm. Keine systemischen Sepsiszeichen (kein Fieber/Lymphangitis).
Schmerz-Assessment (DNQP-Standard)	Numerische Rangskala (NRS 0-10) in Ruhe und bei Belastung/Verbandwechsel. Schmerzqualität.	• Ruhe-Schmerz: NRS 6 / 10 (dumpf-ziehend) • Verbandwechsel-Schmerz: NRS 8 / 10 (stechend-brennend)

4. THERAPIEPLANUNG & KAUSAL-/LOKALTHERAPIE (TIME-PRINZIP)		
Therapieebene	Pflegerisch-Medizinische Maßnahme & Produktwahl	Begründung & Wirkweise
Kausaltherapie (Venenentstauung)	Mehrkomponenten-Kompressionstherapie nach Pütter-Technik (Kurzzugbinden, fortlaufend angepasst). Arbeitsdruck ca. 40 mmHg. <i>Später ab Woche 4:</i> Med. Ulkus-Kompressionsstrumpfsystem (KKL III).	Unterbrechung des venösen Refluxes, Reduktion des Gewebeödems, Wiederherstellung der Perfusion im Kapillarnbett.
T - Tissue (Wundreinigung)	• Aseptische Wundspülung mit Polyhexanid-Lösung (Prontosan®), Einwirkzeit 10 Minuten. • Mechanisches Débridement mit Monofilament-Pad (Debrisoft®).	Bruch der Biofilm-Matrix, Ablösung von Fibrinbelegen ohne Schädigung von intaktem Granulationsgewebe.

I - Infection (Antiseptik)	Lokalantiseptik mit Polyhexanid. Verzicht auf systemische Antibiose (keine Phlegmone/Sepsiszeichen).	Zielgerichtete Keimzahlreduktion ohne Resistenzbildung oder Zytotoxizität.
M - Moisture (Exsudatmanagement)	- Primärverband: Hydrofaser (Aquacel® Extra). - Sekundärverband: Absorptionsstarker Silikon-Schaumstoffverband (Mepilex® Border) unter der Kompression.	Vertikale Exsudatabsorption, Gelbildung schließt Keime ein, verhindert Leckagen unter Kompression.
E - Edge (Wundrandschutz)	Auftragen von barrierebildendem Acrylat-Hautschutz (Cavilon® Wundrandschutz-Lolly) auf den mazerierten Wundrand.	Schutz vor proteolytischen Enzymen im Exsudat, Stopp der Mazeration, Förderung der Epithelisation.
Schmerztherapie & Verbandwechsel	- Prämedikation: WHO-Stufe-I Analgetikum (1.000 mg Metamizol p.o. 30 Min. vor Verbandwechsel). - Wechselintervall: Initial alle 48h (Mo/Mi/Fr), ab Woche 4 2x wöchentlich.	Ausschaltung von Schmerzspitzen, Vermeidung von Kompressions-Verweigerung (Erhöhung der Patienten-Adhärenz).

5. EVALUATION UND VERLAUFSKONTROLLE (8-WOCHEN-MONITORING)

Zeitpunkt	Wundabmessung (L x B)	Wundfläche	Wundgrund & Exsudat	Schmerz (NRS)	Therapieanpassung
Woche 1 (Initial)	5.4 cm x 3.0 cm	16.2 cm² (100 %)	60% Fibrin, 35% Granulation. Starkes Exsudat, Mazeration.	Ruhe: NRS 6 VW: NRS 8	Start Pütter-Kompression, Polyhexanid, Hydrofaser, Cavilon
Woche 2	4.8 cm x 2.5 cm	12.0 cm² (74.1 %)	30% Fibrin, 65% Granulation. Mäßiges Exsudat, Wundrand trocken.	Ruhe: NRS 4 VW: NRS 5	Fortführung Débridement & Hydrofaser, Kompression stabil
Woche 4	3.2 cm x 1.8 cm	5.76 cm² (35.5 %)	10% Fibrin, 80% Granulation, 10% Epithel. Geringes Exsudat.	Ruhe: NRS 2 VW: NRS 2	Umstellung auf Ulkus-Strumpfsystem (KKL III), VW-Intervall 2x/Woche
Woche 6	1.8 cm x 1.1 cm	1.98 cm² (12.2 %)	90% Granulation, 10% Epithel. Minimales Exsudat.	Ruhe: NRS 1 VW: NRS 1	Wechsel auf Wunddistanzgitter + Schaumstoff, Strumpf beibehalten
Woche 8 (Abschluss)	0.8 cm x 0.5 cm	0.40 cm² (2.5 %)	95% Epithelisation, Wunde nahezu geschlossen. Kein Biofilm.	Ruhe: NRS 0 VW: NRS 0	Erhaltungstherapie: Med. Kompressionsstrümpfe KKL III + Lanolinfreie Hautpflege

6. EDUKATION, INTERPROFESSIONELLE SCHNITTSTELLEN & REFLEXION

Patientenedukation & Beratung (DNQP)	Schnittstellenmanagement & Reflexion
Adhärenz-Förderung: Aufklärung über die Kausalität der Veneninsuffizienz. Erklärung, warum Kompression trotz anfänglichem Druckgefühl unumgänglich ist. Bewegungsübungen: Anleitung zu Fuß-Großzehen-Heber-Übungen im Sitzen zur Aktivierung der Wadenmuskelpumpe. Entstauungslagerung: Hochlegen der Beine in Ruhephasen (über Herzniveau). Hautpflege: Tägliche Pflege der Umgebungs- und Unterschenkelhaut mit rückfettenden, lanolinfreien Pflegeemulsionen.	Interprofessionelles Team: Enger Austausch zwischen Wundzentrum UKGM, behandelndem Hausarzt in Dautphetal und Diakoniestation Gladenbach. Rezidivprophylaxe: Nach Wundschluss lebenslanges Tragen von medizinischen Kompressionsstrümpfen KKL III zur Vermeidung erneuter Ulzera (Rezidivquote >30%). Kritische Reflexion: Der Hauptgrund für das 14-monatige Therapieversagen war die mangelhafte Kausaltherapie (Furcht vor Kompressionsschmerzen). Durch gezielte Analgesie wurde die Kompression toleriert.

7. FORMELLE BESTÄTIGUNG & CHECKLISTE ZUR HAUSARBEIT-EINREICHUNG

Prüfkriterium / Nachweis	Status	Bemerkung / Nachweisort
Datenschutzkonforme Patientenanonymisierung (DSGVO)	[X] Erfüllt	Patienten-Einverständniserklärung liegt vor (Anhang C)
16-stündige Hospitation im zertifizierten Wundzentrum	[X] Erfüllt	Hospitationsnachweis UKGM Marburg abgestempelt (Anhang B)
Strukturierter ICW®-Wunddokumentationsbogen	[X] Erfüllt	Vollständiger Fotostatus & Wundprotokoll (Anhang A)
Reiner Textumfang Hauptteil (Teil 1 bis 3)	[X] Erfüllt	Exakt 5 DIN-A4-Seiten (Vorgabe: 5 bis max. 8 Seiten)
Eidesstattliche Erklärung eigenhändig unterzeichnet	[X] Erfüllt	Unterzeichnete Erklärung der Hausarbeit beigelegt

Dautphetal, den _____

Marburg, den _____

René Krieg
(Hospitant / Pflegefachmann)

Fachliche Leitung / Praxisanleiter
(UKGM Wundzentrum Marburg)